

11. LA FÉCONDATION

DURÉE : 14:26

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette session explore en profondeur le processus de fécondation, de l'ovulation à la réception du spermatozoïde par l'ovocyte. Les concepts de mobilité ovarienne, de barrières naturelles à la fécondation, et de la reconnaissance membranaire grâce à la ZP3 sont abordés pour comprendre les dynamiques complexes de la reproduction. La session met également en lumière les implications des techniques de fécondation in vitro, soulignant des liens émotionnels et énergétiques essentiels entre la mère et l'enfant, ainsi que l'importance de connaître son histoire personnelle pour une santé holistique.

LA FÉCONDATION

L'OVULATION ET LA MOBILITÉ OVARIENNE

L'**ovulation** est un processus crucial, et il est essentiel de comprendre la **mobilité ovarienne**. La frange de l'ovaire joue un rôle clé dans ce mécanisme.

L'anatomie du petit bassin, de l'utérus et des ovaires est complexe. On y trouve des structures comme les **ligaments larges**, les **ligaments ronds**, et les **ligaments lombo-ovariens**, qui sont tous constitués d'un même tissu.

L'embryologie et l'anatomie de l'utérus révèlent qu'il s'agit d'un repli du **péritoine pariétal postérieur**. Cette structure doit être mobile pour capter l'**ovocyte**. Un mouvement en forme d'hémisphère, lié à la motricité, est nécessaire pour cette capture.

Si l'on considère le système digestif, le **fascia de Tol** s'insère au péritoine pariétal postérieur. En cas d'**appendicite**, par exemple, une perte d'énergie ou une perturbation fasciale peut affecter la mobilité de l'ovaire et empêcher la capture de l'ovocyte.

Le péritoine doit être libre pour permettre la fécondation. Si l'ovocyte n'est pas capté, il peut rester dans la zone pelvienne, entraînant des **fécondations extra-utérines**, qui représentent un danger. Il existe un lien direct entre le vagin et la cavité péritonéale, ce qui souligne l'importance de cette mobilité.

LES BARRIÈRES NATURELLES À LA FÉCONDATION

Chez l'homme, la fécondation est compliquée par l'absence de connexion entre les structures reproductrices, en raison du **tubercule de Müller** et du **canal de Wolff**.

Chez la femme, plusieurs barrières naturelles existent. La première est l'**acidité vaginale**, qui aide à détruire les bactéries indésirables. Ensuite, un **bouchon muqueux** au niveau du col de l'utérus joue un rôle crucial. Ce bouchon s'ouvre une fois par mois, permettant aux spermatozoïdes de passer. En l'absence d'ouverture, le passage est bloqué.

Une fois dans l'utérus, les spermatozoïdes doivent naviguer à travers des **cils** qui les aident à avancer. Ils sont attirés par la chaleur, le sucre et les signaux électriques. Cependant, ce n'est pas un seul spermatozoïde qui réussit, mais un ensemble qui parvient à atteindre l'ovocyte.

LA RECONNAISSANCE MEMBRANAIRE : LA ZP3

Lorsque le spermatozoïde atteint l'ovocyte, il doit se rendre à la zone la plus optimale, où l'**ovocyte** est prêt à accueillir les spermatozoïdes. Sur la membrane de l'ovocyte se trouvent des **glycoprotéines** appelées **ZP3**, qui agissent comme une clé de reconnaissance.

Cette reconnaissance membranaire est essentielle : si elle échoue, la fécondation ne peut pas se produire.

LA FÉCONDATION IN VITRO ET SES IMPLICATIONS

La **fécondation in vitro** (FIV) est une méthode courante, notamment l'**ICSI** (Intracytoplasmic Sperm Injection), où le spermatozoïde est directement injecté dans l'ovocyte. Cette technique contourne la reconnaissance naturelle, ce qui peut entraîner des problèmes de fertilité à long terme.

Les enfants issus de FIV peuvent présenter des complications. Lors des consultations, il est important de poser des questions sur la conception, notamment sur les fausses couches éventuelles. Les utérus peuvent être chargés d'énergie résiduelle liée à ces événements, nécessitant un nettoyage énergétique.

Il est crucial de reconnaître l'enfant, en établissant un lien entre la mère et l'enfant. Les mères doivent établir un contact physique et émotionnel avec leur enfant pour favoriser cette connexion.

L'IMPORTANCE DE CONNAÎTRE SON HISTOIRE

Connaître son histoire est fondamental. Un enfant né d'un don de spermatozoïdes, par exemple, peut porter un mensonge en lui, ignorant ses origines. Les tissus ne mentent pas, et un ostéopathe peut ressentir cette vérité à travers ses mains.

LE RÔLE DE LA POLARISATION DE L'OVOCYTE

L'**ovocyte** est polarisé. Lorsque le spermatozoïde arrive, il provoque une réorganisation des axes de l'ovocyte, créant des axes dorsal-ventral et apico-caudal. Ce moment symbolique est une connexion avec le cœur primitif.

L'ATTAQUE DE LA MEMBRANE OVOCYTAIRE

Les spermatozoïdes doivent passer plusieurs couches pour atteindre la **zona pellucida**. Une fois sur la membrane, la reconnaissance membranaire doit se produire. Le spermatozoïde qui réussit à se lier libère un acide acrosomique, permettant son entrée dans l'ovocyte.

LA PREMIÈRE CELLULE DE VIE

La rencontre des patrimoines génétiques des deux cellules forme la première cellule de vie. Ce processus dynamique donne naissance aux deux premiers **blastomères**, qui sont les premières cellules germes-mères.



Ovule fécondé

Cette recherche sur la polarité et les premières phases de développement embryonnaire est essentielle pour comprendre les bases de la vie.